

# FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

## ESCALA DE RESILIENCIA DE 14 ÍTEMS (RS-14 / ER-14)

Eje II: Procesos Psicológicos • Evaluación Breve de la Capacidad de Resiliencia y Afrontamiento Adaptativo

### 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

|                                 |                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre Oficial (Español)</b> | Escala de Resiliencia de 14 Ítems (ER-14 / RS-14).                                                      |
| <b>Nombre Original</b>          | 14-Item Resilience Scale (RS-14; Wagnild, 2009).                                                        |
| <b>Autores Originales</b>       | Dra. Gail M. Wagnild y Dra. Heather M. Young (1993, 2009).                                              |
| <b>Adaptación Hispana</b>       | Sánchez-Teruel y Robles-Bello (2015), Universidad de Jaén, España.                                      |
| <b>Eje Clínico y Constructo</b> | Eje II: Procesos Psicológicos. Resiliencia, competencia personal y aceptación vital ante la adversidad. |
| <b>Tipo de Instrumento</b>      | Cuestionario de autoinforme breve de 14 reactivos con escala Likert de 7 puntos (1 a 7).                |
| <b>Población y Rango</b>        | Adolescentes y adultos (13 a 85 años). Población general y clínica ambulatoria.                         |
| <b>Tiempo de Administración</b> | 3 a 5 minutos en autoadministración.                                                                    |
| <b>Régimen de Licencia</b>      | Uso clínico y de investigación autorizado bajo citación formal de la adaptación validada.               |

### 2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA RESILIENCIA

La resiliencia psicológica se conceptualiza como un rasgo de personalidad positivo y un proceso adaptativo dinámico que modera los efectos nocivos del estrés agudo y crónico, permitiendo al individuo resistir, adaptarse y recuperarse con éxito frente a experiencias vitales adversas o traumáticas (Wagnild & Young, 1993; Luthar et al., 2000). El modelo teórico original postula cinco pilares constitutivos: perseverancia, autoconfianza, ecuanimidad, sentido de vida y autosuficiencia con sentido de soledad constructiva.

Para responder a la necesidad de cribado clínico ágil, Wagnild (2009) desarrolló la forma abreviada de 14 ítems (RS-14), que sintetiza la varianza esencial de la escala original de 25 ítems conservando dos factores de orden superior:

- Competencia Personal:** Refleja la autoconfianza, la determinación, el ingenio personal, la autoeficacia y la persistencia en el esfuerzo ante barreras complejas.
- Aceptación de Uno Mismo y de la Vida:** Denota la adaptabilidad, el equilibrio emocional, la flexibilidad cognitiva y la aceptación serena de las situaciones que escapan al control personal.

Bajo la perspectiva neurobiológica, la resiliencia se correlaciona con una adecuada conectividad funcional entre la corteza prefrontal ventromedial y la amígdala, una respuesta moderada y eficiente del eje hipotálamo-hipofisario-adrenal (HPA), concentraciones balanceadas de neuropéptido Y (NPY) y dehidroepiandrosterona (DHEA), y una elevada plasticidad sináptica mediada por factor neurotrófico derivado del cerebro (BDNF).

### 3. DOMINIOS EVALUADOS Y COMPOSICIÓN FACTORIAL DE ÍTEMS

| Dimensión Factorial                            | Ítems (14)                          | Nº Ítems | Definición Operativa y Conductas Evaluadas                                                                      |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1. Competencia Personal</b>                 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14 | 11 ítems | Autosuficiencia, perseverancia, determinación, creencia en las capacidades propias y maestría ambiental.        |
| <b>2. Aceptación de Uno Mismo y de la Vida</b> | 7, 8, 12                            | 3 ítems  | Flexibilidad cognitiva, ecuanimidad, autovaloración incondicional y aceptación serena de la realidad inmutable. |

## PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

### 4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA / LATAM

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consistencia Interna</b>           | Excelente fiabilidad en la validación española de Sánchez-Teruel y Robles-Bello (2015; N = 1060): alfa de Cronbach global de 0.89 a 0.93 y coeficiente omega de McDonald de 0.91. Competencia Personal: alpha = 0.87; Aceptación: alpha = 0.76. Estabilidad test-retest $r = 0.85$ a 4 semanas.                                    |
| <b>Estructura Factorial</b>           | El Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) ratifica el modelo bifactorial correlacionado ( $\chi^2/g.l. = 2.14$ , CFI = 0.96, TLI = 0.95, RMSEA = 0.051). Todas las cargas factoriales estandarizadas superan 0.55 (rango: 0.58 a 0.84).                                                                                            |
| <b>Validez Concurrente y Criterio</b> | Correlación directa robusta con Autoeficacia General (Baessler & Schwarzer, $r = 0.68$ ), Optimismo Disposicional (LOT-R, $r = 0.59$ ) y Calidad de Vida Percibida (WHOQOL-BREF, $r = 0.54$ ). Correlación inversa con Depresión (PHQ-9, $r = -0.54$ ), Ansiedad (GAD-7, $r = -0.48$ ) y Afecto Negativo (PANAS-NA, $r = -0.42$ ). |
| <b>Invarianza de Medida</b>           | Invarianza métrica y escalar estricta confirmada por sexo y grupo etario (adolescentes vs. adultos jóvenes vs. mayores), lo que autoriza comparaciones clínicas directas sin sesgo instrumental.                                                                                                                                   |
| <b>Sensibilidad al Cambio</b>         | Sensible al impacto de intervenciones psicoterapéuticas basadas en TCC, Terapia de Aceptación y Compromiso (ACT) y programas de reducción del estrés basados en Mindfulness (MBSR), con incrementos de $d$ de Cohen $> 0.65$ .                                                                                                     |

### 5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

La escala se califica mediante una respuesta tipo Likert graduada de 1 a 7 puntos:

- **Gradación de Respuestas:** 1 = «Totalmente en desacuerdo», 2 = «En desacuerdo», 3 = «Algo en desacuerdo», 4 = «Ni de acuerdo ni en desacuerdo», 5 = «Algo de acuerdo», 6 = «De acuerdo», 7 = «Totalmente de acuerdo».
- **Sentido de Calificación:** No contiene reactivos invertidos. Todos los ítems puntúan de 1 a 7 en sentido positivo de resiliencia.
- **Puntuación Total RS-14:** Suma aritmética directa de los 14 ítems:  $\text{Puntuación Total} = \sum_{i=1}^{14} \text{Ítem}_i$ .
- **Puntuaciones de Subescala:** Competencia Personal = suma de ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13 y 14 (rango 11 a 77). Aceptación de Uno Mismo y de la Vida = suma de ítems 7, 8 y 12 (rango 3 a 21).
- **Rango Total: 14 a 98 puntos.** A mayor puntuación, mayor nivel de resiliencia y recursos de adaptación positiva.

### 6. BAREMOS NORMATIVOS, PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA

| Estratificación       | Puntuación Total | Nivel de Resiliencia                 | Interpretación y Recomendación Clínica                                                                              |
|-----------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Muy Baja</b>       | 14 a 64 puntos   | Vulnerabilidad crítica ( $\leq 64$ ) | Severa fragilidad psicológica ante estresores; alto riesgo de colapso adaptativo. Intervención clínica prioritaria. |
| <b>Baja</b>           | 65 a 73 puntos   | Resiliencia baja / Frágil            | Recursos de afrontamiento insuficientes; propensión a rumiación y desamparo. Entrenamiento en regulación emocional. |
| <b>Media / Normal</b> | 74 a 81 puntos   | Resiliencia moderada                 | Capacidad adaptativa preservada frente a dificultades cotidianas; fluctuaciones ante adversidades graves.           |
| <b>Moderada Alta</b>  | 82 a 90 puntos   | Resiliencia elevada                  | Buen nivel de autoeficacia y aceptación; rápida recuperación funcional ante situaciones estresantes.                |
| <b>Muy Alta</b>       | 91 a 98 puntos   | Fortaleza excepcional                | Excelente capacidad de adaptación, optimismo resiliente, perseverancia y alta tolerancia a la frustración.          |

#### CRITERIO CLÍNICO DE VULNERABILIDAD (CORTE $\leq 64$ PUNTOS):

En pacientes en psicoterapia, una puntuación global en el RS-14  $\leq 64$  predice significativamente un menor cumplimiento de objetivos terapéuticos, mayor frecuencia de recaídas afectivas y elevada desesperanza. En pacientes crónicos o oncológicos, señala riesgo inminente de claudicación psicológica.

## APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

### 7. ALGORITMO DE DECISIÓN TERAPÉUTICA BASADO EN EL PERFIL DE RESILIENCIA

#### PROTOCOLO CLÍNICO DE FORTALECIMIENTO DE LA RESILIENCIA:

- **Paso 1 (Evaluación Diagnóstica y Desagregación):** Si RS-14  $\leq$  64, analizar qué pilar está más deprimido. Si falla Competencia Personal (ítems 1-6, 9-11, 13-14), focalizar en autoeficacia y resolución de problemas. Si falla Aceptación (Ítems 7, 8, 12), intervenir con aceptación radical y defusión cognitiva.
- **Paso 2 (Reestructuración Cognitiva y Activación Conductual):** Reencuadre de atribuciones de fracaso (de internas/estables a externas/modificables); planificación sistemática de actividades de dominio y placer.
- **Paso 3 (Entrenamiento en Flexibilidad Psicológica):** Incorporar componentes de ACT orientados a valores nucleares para que los estresores vitales no paralizen la acción comprometida.
- **Paso 4 (Monitorización y Criterio de Éxito):** Un incremento de  $\geq$  15 puntos en el total de RS-14 o alcanzar el rango de resiliencia moderada ( $\geq$  74) consolida el alta clínica terapéutica.

### 8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN TRAS PÉRDIDA LABORAL Y CRISIS ADAPTATIVA

**Identificación:** Varón de 46 años, exencargado de logística, despedido tras reestructuración empresarial tras 18 años de servicio. Consulta por apatía, autorreproches continuos, insomnio de conciliación y sensación de incompetencia radical para reinsertarse al mercado laboral.

**Evaluación Inicial RS-14 (Línea Base):** Puntuación Total = **48/98 puntos** (Rango de Vulnerabilidad Crítica / Muy Baja Resiliencia). Desglose: Competencia Personal = **36/77 puntos** (percepción de pérdida total de control); Aceptación de Uno Mismo = **12/21 puntos** (intolerancia al cambio involuntario). PHQ-9 concurrente = 14 (depresión moderada).

**Plan Terapéutico:** 12 sesiones de TCC centrada en resiliencia y activación conductual. Se abordaron las creencias distorsionadas de "inutilidad personal", se jerarquizaron metas de actualización tecnológica y se entrenaron habilidades de solución de problemas.

**Reevaluación al Cierre:** Puntuación Total RS-14 aumentó a **80/98 puntos** (+32 pts, normalización en rango de Resiliencia Moderada). Competencia Personal ascendió a **64/77 puntos**. El paciente reactivó su red social profesional y concluyó dos procesos de selección laboral sin desestabilizarse emocionalmente ante el rechazo previo.

### 9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

#### RIESGO DE DESESPERANZA Y SUICIDALIDAD:

Puntuaciones extremadamente bajas (RS-14  $<$  40) correlacionan de forma estrecha con indefensión aprendida y riesgo autolítico. Si coexiste con depresión mayor o pérdidas traumáticas, aplicar de inmediato el protocolo C-SSRS.

#### PSEUDO-RESILIENCIA MANÍACA O DEFENSIVA:

Puntuaciones máximas perfectas (98/98) en pacientes con marcada disfunción psicosocial pueden reflejar negación omnipotente, sesgo de deseabilidad social o fase de hipomanía (contrastar con MDQ y heteroobservación familiar).

### 10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Wagnild, G. M., & Young, H. M. (1993). Development and psychometric evaluation of the Resilience Scale. *Journal of Nursing Measurement*, 1(2), 165-178.
2. Wagnild, G. M. (2009). *The Resilience Scale User's Guide: For the US English version of the Resilience Scale and the 14-Item Resilience Scale (RS-14)*. Resilience Center.
3. Sánchez-Teruel, D., & Robles-Bello, M. A. (2015). Escala de Resiliencia 14 ítems (RS-14): Propiedades psicométricas de la versión en español. *Revista Iberoamericana de Diagnóstico y Evaluación Psicológica*, 2(40), 103-113.
4. Luthar, S. S., Cicchetti, D., & Becker, B. (2000). The construct of resilience: A critical evaluation and guidelines for future work. *Child Development*, 71(3), 543-562.